

Relatório Territorial

Alto Acre

AC · código 12001

Inteligência territorial em saúde mental no Brasil.

População	75.243
Municípios	4
Release analítico	MDB_ANALYTICAL_2024_2
Intelligence version	MDB_TERRITORIAL_INTELLIGENCE_1.1
Need	0,33
Capacity	0,35
Mismatch	-0,01
Radar	1/5 famílias

Sinal de desalinhamento territorial relativo entre necessidade medida e capacidade registrada.

Por que chamou atenção

A região aciona 1 das 5 famílias de sinais do Radar. O Mismatch é -0,01. As maiores contribuições algébricas vêm de Psiquiatras FTE e Internações psiquiátricas. A leitura funciona como sinal para investigação territorial, sem prescrição automática.

Radar	Ao menos um componente de Capacity está em faixa relativamente baixa.
Sub-sinal	Psiquiatras FTE no SUS em faixa relativamente baixa.
Sub-sinal	Zero leitos de saúde mental SUS registrados neste release.

Cautelas

Zero leitos registrados neste recorte deve ser interpretado junto à organização regional, referências intermunicipais e cadastro.

Decomposição do Mismatch

Componente	Percentil	Contribuição algébrica
Suicídio	P44	-0,03
Internações psiquiátricas	P23	-0,14
CAPS	P72	-0,07
Leitos SUS	P31	+0,06
Psiquiatras FTE	P1	+0,16

Need e Capacity

Indicador	Valor	Percentil
Suicídio	8,30	P44
Internações psiquiátricas	45,69	P23
CAPS	2,66	P72
Leitos SUS	0,00	P31
Psiquiatras FTE	0,00	P1

Os indicadores são públicos e organizados para investigação territorial. Não constituem inferência clínica.

Peers estruturais e contexto espacial

Comparação com 10 Regiões de Saúde estruturalmente semelhantes segundo população, densidade populacional e número de municípios.

Método de peers	MDB_PEER_METHOD_1.0		
Métrica padrão	Mismatch		
Métrica	Região	Mediana dos peers	IQR dos peers
Mismatch	-0,01	0,06	-0,01 - 0,15
Need	0,33	0,47	0,38 - 0,61
Capacity	0,35	0,34	0,30 - 0,53

Contexto espacial

LISA significativo: low-high.

Evolução territorial / O que mudou?

Need utiliza janelas móveis de três anos. Capacity utiliza registros de dezembro. São três pontos observados, sem suavização ou inferência causal.

Âncora	Need	Capacity	Mismatch	Janela de Need
2022	0,556	0,369	0,187	2020-2022
2023	0,450	0,412	0,037	2021-2023
2024	0,332	0,347	-0,015	2022-2024

Entre 2022 e 2024: 0 famílias de mudança relativa atendidas.

Delta Need: -0,224; Capacity: -0,022; Mismatch: -0,202.

Contexto de financiamento da saúde

Esta medida descreve o financiamento geral da saúde e não corresponde a gasto específico em saúde mental.

Ano	Total em saúde (R\$)	R\$/habitante	Municípios
2022	57.725.838,460	784,400	4/4
2023	64.229.454,640	863,460	4/4
2024	80.646.466,180	1.071,810	4/4

Valores em reais correntes do respectivo exercício; comparações entre anos não representam variação real descontada da inflação. Dados parciais não são zero. SIOPS: PASS_WITH_LIMITATIONS.

Fluxos de internações psiquiátricas

Os dados representam internações/AIHs, não pacientes únicos. Janela 2022-2024. Origem: município de residência; destino: município do estabelecimento.

Medida	Valor
AIHs de residentes	102
Proporção na própria região	0,196
Proporção fora da região	0,804
Proporção fora da UF	0,000
Destino	AIHs
Baixo Acre e Purus	81
Alto Acre	Indisponível (supressão)
Juruá e Tarauacá/Envira	Indisponível (supressão)

Contribuições com menos de cinco internações não são divulgadas. Pares regionais com contribuições suprimidas não recebem totais exatos na tabela.

Perguntas para investigação

1. Como o contexto geral de financiamento da saúde desta região se relaciona com a organização local da rede?

Origem: Financing. Contexto descritivo para a agenda de investigação.

2. Quais referências assistenciais, serviços disponíveis ou pactuações regionais ajudam a explicar as internações de residentes realizadas fora da própria região?

Origem: Flow. Contexto descritivo para a agenda de investigação.

3. Zero leitos registrados neste recorte reflete ausência de cadastro local, referenciamento para outras regiões ou outra organização assistencial?

Origem: Quality. O release registra zero leitos SUS de saúde mental.

4. Como a carga horária de psiquiatria registrada no SUS está distribuída entre os serviços e municípios da região?

Origem: Capacity. Psiquiatras FTE no SUS estão em faixa relativamente baixa.

5. Qual aspecto deste retrato territorial é confirmado pela experiência local?

Origem: Base. Toda leitura territorial exige confronto com conhecimento local.

6. Qual aspecto pode estar sendo influenciado por fluxo entre regiões, cadastro ou organização da rede?

Origem: Base. Indicadores regionais podem refletir organização territorial e registros.

7. Quais dados locais seriam necessários para interpretar estes sinais com mais segurança?

Origem: Base. O produto organiza sinais públicos e não substitui investigação local.

Limitações e leitura correta

Este relatório organiza indicadores públicos e sinais territoriais para apoiar investigação. Não constitui avaliação direta de acesso, qualidade, necessidade não atendida ou recomendação automática de recursos.

Fontes e versões

Fontes: SIM; SIH/SUS; CNES; IBGE/geografia. MDB_ANALYTICAL_2024_2; MDB_TERRITORIAL_REPORT_2.0; MDB_INVESTIGATION_GUIDE_2.0; conteúdo 8d578726e316073182eec39898eeb77539e8367d1e722053aca97c8142f6252e.

Citação sugerida: Mente do Brasil. Relatório Territorial — Alto Acre. Release MDB_ANALYTICAL_2024_2. MDB_TERRITORIAL_REPORT_2.0.